| 보건복지부 | 보도자료 | 대체불가 대한민국 |
|---|---|---|

보도시점 2026. 10. 28.(수) 위원회 종료(별도 안내) 이후 배포 2026. 10. 28.(수)

# 지역·필수의료 수가 2.7조 원 우선 투입, '27년 1월부터 본격 수가 구조 혁신

- 지역·필수의료 수가 2.7조 원 상향, 과보상 검체·CT·MRI 수가는 연 2.6조 원 조정 -

- 의원·치과 초진 진찰료, 병원 주사료·식대 인상 -

- 검사의 질 향상을 위한 위·수탁기관 조건부 보상 추진 -

- 마약류 중독환자 치료지원과 어린이 재활의료기관 운영 시범사업 논의 -

**보건복지부**(장관 정은경)는 10월 28일(수) 오후 2시에 **2026년 제19차 건강보험정책심의위원회**(이하 '건정심', 위원장 : 이형훈 제2차관)를 **개최해 ▲지역과 필수의료 강화를 위한 건강보험 수가 구조 혁신방안 이행 ▲환산지수-상대가치 연계 수가 조정(안) ▲검체검사 위·수탁 조건부 보상 추진계획**을 의결하고, **▲마약류 중독환자 치료지원 시범사업 ▲어린이 재활의료기관 지정·운영 2기 시범사업 성과평가** 안건을 논의하였다.

**건정심**에서 논의된 **안건**의 **주요 내용**은 다음과 같다.

## < 지역과 필수의료 강화를 위한 건강보험 수가 구조 혁신방안 이행 >

내년 1월부터 ▲분만과 신생아 중환자 치료 분야부터 비수도권과 수도권 취약지를 우대하는 **지역우대 수가를 본격 적용**하고, **▲최종치료 역량 강화**에 **연간 9천억 원, ▲소아 및 분만 분야에 연간 4천억 원의 보상을 본격 강화**한다.

오늘 건정심에서는 이러한 내용을 담은 「**건강보험 수가 구조 혁신방안 이행 방안**」을 의결하였다고 밝혔다.

오늘 의결한 이행방안은 지난 제12차 건강보험정책심의위원회('26.6.25)에서 확정한 「**건강보험 수가 구조 혁신방안**」의 **후속조치**로서 **시행일 등 추진계획**을 **확정**하였다. 지역·필수의료 강화를 위한 연간 **3.6조 원 투자계획 중 2.7조 원의 시행시기를 확정**하였고, 나머지 **9천억 원은 금년 중 건정심에서 추가 논의**하여 **시행시기를 확정**할 예정이다. 또한 **내년 1월부터 검체검사와 컴퓨터단층촬영(CT)·자기공명영상(MRI) 검사 수가 조정과 위·수탁체계 개편을 시행**하여 **연간 2.6조 원의 과다지출을 절감**한다.

**【 참고 : 건강보험 수가 구조 혁신방안 보도자료 발췌 】**

◇ **현행 수가체계 도입('01) 이래, 역대 최대 규모 조정**

**❶ 지역 우대수가 적용**

◇ **비수도권과 수도권 취약지, 건강보험 수가 우대 원칙 확립**

◇ **연 4천억 원 보상 강화, 단계적 확대**

**❷ 필수 기본진료 강화**

◇ **20년 만에 진찰료 상향, 기본보상 높이고 심층진찰 본격 확대**

◇ **진찰료, 입원료 연 1.5조 원 보상 강화**

**❸ 중증·응급 최종치료 보상 대폭 확대**

◇ **1,600여 개 중증수술·시술 보상 확대, 공휴·야간 응급 시 5.5배**

◇ **중증·응급 수술, 시술, 마취 등에 연 9천억 원 보상 강화**

**❹ 걱정없는 모자·소아 의료환경 조성**

◇ **고위험산모 안심 분만 위해 모자센터 중심 연 1천억 원 보상 강화**

※ 모자센터 지역 우대수가(❶), 임신분만 수술·마취 보상(❸) 포함 시 약 2천억 원

◇ **소아의 진찰, 입원부터 중증수술 등 연 2천억 원 보상 강화**

**❺ 급성기-회복기 의료공급·이용체계 확립**

◇ **급성기에서 회복기까지 공급체계 확충에 연 5천억 원 보상 강화**

**❻ 검체검사, CT·MRI 과다지출 합리화**

◇ **혈액검사 등 검체검사 △28%, CT·MRI △25%, 연 2.6조 원 절감**

◇ **검체검사료 조정과 연동하여 위·수탁 보상 명확화, 질관리 기전 강화**

## 【 주요내용 】

### 1. 비수도권, 수도권 취약지 등 지역 우대수가 확립

| 구분 | 지역 우대수가 내용 | 시행시기 |
|---|---|---|
| 적용 지역 | 비수도권 + 수도권 취약지<br>(경기 의정부권, 남양주권, 이천권, 포천권,<br>인천 서북권, 중부권) | |
| 수술·처치 | +10% 가산 *종합병원 이상 | '27.3월 |
| 야간·휴일·응급 | +10% 가산 *종합병원 이상 | '27.3월 |
| 고위험 분만 | 모자의료센터 내 분만 100%,<br>신생아중환자실 입원 및 처치 50% 가산 | '27.1월 |
| 중증소아 처치 | 50% 가산 *상급종합병원, 소아중환자실 있는 종합병원 | '27.3월 |
| 적용 지역 | 인구감소 지역 (86개 시군구) * 종합병원, 병원, 의원 | |
| 진찰 및 입원 | +5% 가산 | '27.3월 |

내년부터 **비수도권과 수도권 취약지**에서 이루어지는 종합병원급 이상의 ▲수술·처치, ▲야간·휴일·응급 수술, ▲모자센터의 고위험 분만과 신생아 중환자 치료, ▲중증 소아의 처치 등에 **연간 3천억원의 지역 우대수가를 우선 적용**한다.

* 지역우대수가 4천억원 중 1천억원은 건정심 추가 심의를 거쳐 시행 예정

내년 1월부터는 **진료비의 본인부담이 발생하지 않는 분만과 신생아 중환자의 입원치료 등에 우선 적용**한다.

**내년 3월**부터는 **수술·처치 등에 폭넓게 적용**한다. 지역 우대수가로 추가로 보상하는 부분에 대해서는 **본인부담이 발생하지 않도록 건강보험법령 개정을 함께 추진**한다.

첫째, 비수도권과 수도권 6개 취약지에 있는 **종합병원 이상 의료기관**에서 시행하는 2,740개의 **모든 수술·처치 행위는 수가의 10%를 가산**한다.

둘째, 같은 중증수술이라 하더라도 **야간·휴일 응급 상황**에서 이루어지는 경우 **더 보상**을 받도록 하면서, **비수도권과 수도권 취약지**에서는 **10%를 추가로 보상**한다.

※ 지역소재 권역응급센터 기준, 야간·휴일 응급 중증수술 가산 (현행) **최대 350%** → (개편) 450% 상향하고 비수도권·수도권 취약지 +10% 추가(야간·휴일 중복 적용), **최대 470%**

셋째, **상급종합병원과 소아중환자실이 있는 종합병원**에 대해서는 소아중환자실에서 이루어지는 **모든 시술·처치에 대해 50%를 가산**하면서 이 중 **비수도권과 수도권 취약지에는 추가로 50% 가산을 적용**한다.

넷째, **인구감소지역으로 지정된 지역 중 86개 시군구**('26.10월 기준)에 소재한 종합병원, 병원, 의원 등에는 **진찰료를 5% 가산**하고, 종합병원, 병원 등은 **입원료를 5% 가산**한다.

**지역 우대수가를 적용하는 지역**은 「필수의료 강화 지원 및 지역 간 의료격차 해소를 위한 특별법」에 따른 진료권과 취약지 세부 분석 등을 거쳐 지속 **조정**해나갈 계획이다. 또한, 지역 우대수가를 적용하는 분야도 **지역별 의료수요 등을 파악하여 지속 확대해 나갈 예정**이다.

## 2. 필수적 기본진료 중심으로 전환

내년 1월부터 **20년간 고정된 진찰료와 10여년간 유지되어 온 입원료**를 **상향**하여 환자에게 **필수적인 기본진료 보상을 대폭 강화**한다.

### 1 진찰료 ('27.1월 시행)

첫째, 진찰료 저보상 수준을 감안하여, 의원급의 경우 **진찰료 상대가치점수**를 **초진 6%, 재진 4% 각각 높인다.** 병원급 이상은 초진, 재진 모두 2% 상향한다.

* (예시) 방문 1회당 진찰료 의원급 초진 기준 18,840 → 19,980원

둘째, **충분한 진찰과 상담에 상응하는 보상**을 할 수 있도록 **심층 진찰을 본격화**한다. 현재 시범사업으로 시행되는 **상급종합병원 심층진찰**과 **아동 일차의료 심층상담**을 **본 사업으로 전환**한다.

특히 상급종합병원 심층진찰의 경우 ▲환자 당 횟수를 현행 연 4회에서 **연 6회, 8세 미만의 경우 연 8회로 확대**하고, ▲별도 요일이나 시간을 분리하여 운영하던 기준을 개편하여 **언제든지 심층진찰을 할 수 있도록 전환**한다.

향후 **일부 종합병원**과 **의원급**(내과, 가정의학과, 산부인과)을 대상으로 **심층진찰** 시범사업을 추진할 수 있도록 **연내 건정심 심의를 통해 구체적인 방안을 발표할 예정**이다.

셋째, 만성질환 교육·상담체계 갖춘 의원에 적용하던 **만성질환관리료*를** 11개 상병군에서 **2개 상병군(류마티스, 만성호흡기질환) 추가**하고, **현행 대비 20%, 2개 이상의 복합질환자에는 30~50% 가산을 적용**한다.

* 현재는 고혈압 등 11개 상병에 회당 2,320원(연 최대 12회) 적용

### ② 입원료 ('27.1월 시행)

환자들이 **더 나은 입원서비스를 제공받을 수 있도록 입원료 보상을 강화**하고 **간호인력 투입이 높은 경우 더 많은 보상**을 받을 수 있도록 전환한다.

첫째, 입원료가 비용 대비 수익이 저보상되어 있는 점을 고려하여 **10년 이상 고정된 입원료 기본수가를 상향(일반병실 7%, 중환자실 10%)**한다.

둘째, **입원료 기준등급*을 ▲병원급 일반병동 4등급에서 2등급, ▲종합병원급 중환자실 3등급에서 2등급**으로 각각 상향한다. 또한 간호차등제 가산율을 ▲일반병동 **상급종합병원(현행 15%)과 종합병원(현행 12%) 18%, 병원(현행 10%) 14%로 확대**하고, ▲중환자실 20%에서 **25%로 확대**하여 간호인력 투입 보상을 강화한다.

* 입원료는 간호인력 배치수준에 따라 등급을 나누고, 기준등급을 정해 기준등급보다 간호인력을 더 많이 투입한 경우 입원료 가산

■ 입원료 개편시 변화 예시 :
상급종합병원 중환자실 간호등급(S) 현행 66.8만 원→ 79.8만 원
종합병원 4인실 일반병실 간호등급(A) : 현행 12.7만 원→ 14.3만 원

셋째, 뇌졸중 및 고위험임산부 집중치료실에 **간호배치 최상위 구간을 신설**하여 보상을 강화하고, **격리실과 신생아실의 입원료도 상향한다.**

* 격리실 15%, 중환자 격리관리료 40%, 상종신생아실(질병 無 24%, 질병 有 63%, 모자동실 63%) 보상 강화

## 3. 중증 · 응급 최종치료 보상 강화

| 현행 | 개선 | |
|---|---|---|
| 응급실 ⇨ 수술 등으로 이어지는 최종 치료 보상이 낮다는 비판 | 중증 수술·시술 | 1,670개 20% 상향<br>*종합병원 이상 |
| | | 응급·야간·휴일 350%→ 450% 가산<br>*권역(외상), 전문, 응급센터 이상 |
| | 마취 | 전신마취, 중증수술 동반마취, 고난도 특수마취 가산 등 현행 대비 50% 인상<br>* 전신마취, 중증수술 동반마취 종합병원 이상 |

첫째, 종합병원 이상 의료기관에는 **전체 수술 수가의 61%에 해당하는 1,670개 중증 수술·시술*** 건강보험 수가 수준을 20% 상향한다. 심뇌혈관, 급성 복증 등의 응급 관련 수술·시술과 암 등 중증 수술, 복합골절과 재건성형, 동맥관 개존증 등 선천성 기형 관련 시술 등 **난이도가 높고 숙련된 인력 투입이 많은 수술·시술을 대상**으로 한다.

*** ① (다빈도 중증수술) 상급종합병원, 종합병원 입원 70% 이상 시행하는 수술·시술 등**
**② (고난도 중증선별) 복합골절, 외상 등 응급수술, 재건성형 및 감염성 근골격계 수술 등**

둘째, **휴일·야간에 응급으로 입원한 환자**에 대해서는 **응급실 내 응급처치* 가산을 50% 인상**한다. **야간·휴일과 응급상황** 등 시급성이 높을수록 보상 수준을 높여 **중증응급 환자에 대한 최종치료 역량을 강화**한다.

* 응급천자, 이물제거, 화상처치, 천두술, 혈액투석 등(제19장 응급의료수가 [별표2] 응급의료행위)

셋째, 수술과 시술뿐 아니라 마취 등 **응급 최종치료에 수반되는 마취**에 대한 **보상도 확대**한다. 종합병원 이상 의료기관의 **전신마취에 대한 수가 수준을 현행 대비 10~50% 상향**하고, 1,670개 **중증 수술·시술과 이에 동반되는 마취**에 대한 **야간·공휴일 가산을 현행 100%에서 150%로 강화**한다. 고난도 마취에 적용하는 **특수마취 가산을 확대***한다.

* 이식, 심장수술, 개두술(뇌출혈 추가) 등 특수마취 가산 50% 인상, 분만마취 특수마취 대상으로 적용

## 4. 걱정없는 모자·소아 의료체계 구축

### 1 모자의료체계 강화 ('27.1월 시행)

#### ❶ 모자의료센터 공급체계 개편과 연계한 보상 강화

| 현행 | 개선 | |
|---|---|---|
| 모자센터 지정됐지만, 고위험 산모와 미숙아 적극 치료 유인 부족<br>* 분만당 176만 원 가산 도입('23.12.~) 다만, 고위험 산모·신생아 치료 전담 모자센터 인센티브 부족 | 중증 모자센터 응급 이송전원 | 34주 미만 조산아 분만, +264만 원 가산<br>* 비수도권 분만은 +330만 원 가산 |
| | | 신생아 중환자실 입원료 최대 2.5배 적용<br>* 비수도권은 최대 3배 적용 |
| | 권역 모자센터 응급 이송전원 | 34주 미만 조산아 분만, +165만 원 가산<br>* 비수도권 분만은 +231만 원 가산 |
| | | 신생아 중환자실 입원료 최대 2배 적용<br>* 비수도권은 최대 2.5배 적용 |
| | 지역분만 기능강화 모자센터 응급 이송전원 | 34주 미만 조산아 분만, +66만 원 가산<br>* 비수도권 분만은 +132만 원 가산 |
| | | 신생아 중환자실 입원료 최대 1.2배 적용<br>* 비수도권은 최대 1.5배 적용 |

**모자의료센터에 대한 보상 수준을 대폭 높인다.** 모자센터를 중심으로 고위험 산모와 신생아 중환자를 돌보는 의료기능과 **인력, 인프라를 강화**하도록 **모자의료 공급체계 개편**과 **보상의 연계를 강화**하는 것이 목표이다.

첫째, **중앙모자센터 등에서 환자를 응급 전원·이송**하는 경우, **이를 수용하는 모자센터에 대한 기능 수가**를 도입한다. **중증 모자센터를 비수도권까지 확충**하고 위험도·난이도가 높은 분만과 신생아 중환자 치료에 대한 **모자센터의 기능을 강화**하는 「**모자의료 공급체계 개편**」에 맞추어 중증, 권역, 지역 모자센터에 **기능별 차등수가를 적용**한다.

둘째, ▲24주 미만, ▲24~28주, ▲28~32주의 **주수별로 보다 세분화된 차등수가**를 적용한다.

위 두 가지의 ▲**응급 전원·이송에 대한 모자센터 기능수가**와 ▲**주수별 차등수가**는 **고위험 분만**과 **신생아 중환자 치료**에 **적용**하여 **한 번의 분만** 뿐 아니라 **신생아 치료 과정에 적용**하여 실질적인 보상이 이루어지도록 한다.

**고위험 분만**과 **신생아 중환자실 치료**에 적용되는 **건강보험 보상 강화의 구체적인 내용**은 다음과 같다.

**모자센터의 분만 보상 강화방안**

■ 응급 전원·이송시 적용 센터 기능수가

*** 중앙모자센터의 환자 분류에 따른 응급 전원·이송으로 모자의료센터 입원**
**** 중앙모자센터에서 응급 전원·이송된 이력이 확인되는 경우 적용**
**(119 구급상황센터를 통한 병원 배정, 모자의료협력체계 내 수용병원 배정 이력 포함)**

34주 미만의 고위험 분만을 수용할 병원이 없어 **중앙모자센터에서 전원·이송을 결정**하는 경우, **이를 수용하는 중증모자센터**는 **현행 분만 보상**(약 400만원)에 더하여 **264만원**의 **기능수가를 보상**한다. 비수도권 또는 수도권 6개 취약지에 위치한 중증모자센터인 경우에는 여기에 66만원의 지역우대수가를 더하여 **330만원을 추가로 보상**한다.

서울 소재 중증모자센터 2개소에서 더하여 **내년부터 비수도권 중증모자센터를 확충**할 예정으로, 보상 강화와 연계하여 **지역의 모자의료 기능이 더욱 강화**될 것으로 기대된다. **중증, 권역, 지역모자센터**에 따라 보상의 수준을 차등하여 적용하는 만큼 중증모자센터는 응급 대기 병상을 확보토록 하는 등 **기능을 강화하는 모자의료 공급체계 개편도 추진**한다.

| | 현행 | | 개편 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 중증 (2개소) | 권역 (20개소) | 지역 (15개소) *분만기능강화 |
| 모자센터 | 분만수가 *자연분만 약 80만원/ 제왕절개 약 300만원 (상종 기준) | 안전수가 55만원 + 고위험마취 11만원 = 66만원(A) *지역수가 55만원 별도 | 264만원 *A의 400% (지역우대 66만원) *A의 100% | 165만원 *A의 250% (지역우대 66만원) *A의 100% | 66만원 *A의 100% (지역우대 66만원) *A의 100% |
| 일반 | | | 34주 미만 응급 전원이송 | | |

■ 주수별 차등 가산

현재 34주 미만의 고위험 가산에 더하여 모자센터에는 **주수별로 보다 세분화된 주수차등 가산을 적용**한다.

**현행 분만 보상**(약 400만원)에 더하여 ▲**24주 미만 또는 750g 미만의 신생아 분만**은 **132만원**(지역우대수가 적용시 198만원), ▲**24주 이상 28주 미만** 또는 **750~1,000g 미만 신생아 분만**은 **66만원**(지역우대수가 적용 시 132만원), ▲**28주 이상 32주 미만** 또는 **1,000~1,500g 미만 신생아 분만**은 **33만원**(지역우대수가 적용 시 99만원)의 보상을 강화한다.

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">현행</th><th colspan="4">개편</th></tr>
<tr><td rowspan="4">모자센터</td><td rowspan="4">분만수가<br><br>*자연분만<br>약 80만원/<br>제왕절개<br>약 300만원<br>(상종 기준)</td><td rowspan="4">34주 미만은<br>분만수가의<br>고위험분만<br>가산<br>100~200%</td><td></td><td>중증<br>(2개소)</td><td>권역<br>(20개소)</td><td>지역<br>(15개소)<br>*분만기능강화</td></tr>
<tr><td>24주 미만<br>750g 미만</td><td colspan="3">132만원 *A의 200%<br>(지역우대 66만원 / A의 100%)</td></tr>
<tr><td>24~28주 미만<br>750~1000g</td><td colspan="3">66만원 *A의 100%<br>(지역우대 66만원 / A의 100%)</td></tr>
<tr><td>28~32주 미만<br>1000~1500g</td><td colspan="3">33만원 *A의 50%<br>(지역우대 66만원 / A의 100%)</td></tr>
<tr><td>일반</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

* 응급 전원이송시 기능가산과 주수별 차등가산은 중복하지 않음

## 신생아중환자실 가산 적용방안

■ 응급 전원·이송시 적용 센터 기능수가

*** 중앙모자센터의 환자 분류에 따른 응급 전원·이송으로 모자의료센터 입원**
**** 중앙모자센터에서 응급 전원·이송된 이력이 확인되는 경우 적용**
**(119 구급상황센터를 통한 병원 배정, 모자의료협력체계 내 수용병원 배정 이력 포함)**

34주 미만의 고위험 분만을 수용할 병원이 없어 **중앙모자센터에서 전원·이송을 결정**하는 경우, 분만 뿐 아니라 **신생아 중환자 치료에 대한 입원 보상**도 이루어지도록 **가산 수가를 신설**한다.

**중앙모자센터에서 34주 미만 분만과 신생아 치료에 대한 전원·이송을 결정**하는 경우, **이를 수용하는 중증모자센터**는 **현행 신생아 중환자 입원료**(95.7만원/일)에 더하여 일당 입원료의 150%에 해당하는 **144만원을 추가로 보상**한다. 비수도권 또는 수도권 6개 취약지에 위치한 중증 모자센터는 여기에 **입원료의 50%(약 48만원)의 지역우대수가를 더하여 일당 입원료 191만원을 추가로 보상**한다. 이 보상은 **최대 7회** 적용한다.

| | 현행 | 개편 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 중증 (2개소) | 권역 (20개소) | 지역 (15개소) *분만기능강화 |
| 모자센터 | 별도 가산 없음 | 34주 미만 응급 전원이송 | 입원료의 150% 가산 (지역우대 +50%) | 100% 가산 (지역우대 +50%) | 20% 가산 (지역우대 +50%) |

* 상종 NICU S등급 입원료 기준(95.7만 원/일당), 가산 시 중증모자센터 약 144만원 가산(지역우대 포함 시 191만원 가산)
권역모자센터 96만원 가산(지역우대 포함시 144만원 가산), 지역모자센터 약 19만원 가산(지역우대포함시 67만원 가산)
** 해당 주수 기간만큼 지원하되, 최대 7회

■ <u>주수별 차등 가산</u>

분만과 마찬가지로 신생아 중환자에 대해서는 **주수별 입원료 차등가산**을 적용한다. **현행 신생아 중환자 입원료**(95.7만원/일)에 더하여 ▲**24주 미만 신생아는 입원일당 19만원**(지역우대수가 적용시 67만원), ▲**24주 이상 28주 미만 신생아**는 **14만원**(지역우대수가 적용 시 62만원), ▲**28주 이상 32주 미만 신생아**는 약 **9만원**(지역우대수가 적용 시 57만원)의 보상을 **신설**한다.

| | 현행 | 개편 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 중증 (2개소) | 권역 (20개소) | 지역 (15개소) *분만기능강화 |
| 모자센터 | 별도 가산 없음 | 24주 미만 | 입원료의 20% 가산 (지역우대 +50%) | | |
| | | 24~28주 미만 | 입원료의 15% 가산 (지역우대 +50%) | | |
| | | 28~32주 미만 | 입원료의 10% 가산 (지역우대 +50%) | | |

* 상종 NICU S등급 입원료 기준(95.7만 원/일당), 24주 미만 약 19만원(지역우대 포함 시 67만원 가산)
* 응급 전원이송시 기능가산과 주수별 차등가산은 중복하지 않음

■ 신생아중환자 처치 가산

신생아 중환자는 입원 중에도 다양한 처치행위가 발생하는 점을 고려하여 **중증모자센터와 권역모자센터 신생아중환자실에서 시행하는 처치**에 대한 **50% 가산수가를 신설**하고, 비수도권과 수도권 취약지에서는 여기에 **50%를 지역우대수가로 추가 가산**한다.

## ❷ 임신분만 관련 수가 상향 및 고위험 분만, 고위험임산부 보상 강화

**임신·분만 관련 210개 수술·시술에 대한 상대가치점수를 20% 상향**하고 모든 분만병원에 적용하고, **고위험분만**에 대해서는 **자연분만과 제왕절개 모두 일반분만 수가에 100~200% 가산을 적용**한다. 또한 **고위험임산부 집중관리료 수가를 확대***하여 **고위험 임산부의 산전 관리에 대한 보상 수준**을 상향한다.

* 신생아중환자실(NICU) 보유한 종합병원 이상에 고위험임산부 집중관리료 100% 인상 (상종 기준 1일 3.5→7만원) 및 산정일수 확대(7→10일) 적용

**【 24주 미만 고위험 분만 및 신생아 중환자 치료시 보상 변화 (비수도권 중증모자센터 기준) 】**

* 분만 및 신생아중환자 입원료만 고려 시 보상 수준 예시 (28일 간)

| | | 현행 | 보상 강화 | 최종 보상금액 |
|---|---|---|---|---|
| 분만 | | **420만원**<br>*제왕절개 상종기준, 300만원 + 정책수가 약 120만원 | **최대 +462만원**<br>* 응급이송 기능가산 264만원 + 지역우대 66만원 + 제왕절개고위험가산 66~132만원 | **882만원** |
| 신생아 중환자치료 | 7일 | **670만원**<br>*95.7만원(일)×7일 | **+1,337만원**<br>*응급이송 기능가산 +지역우대 191만원(일)×7일 | **2,007만원** |
| | 21일 | **2,010만원**<br>*95.7만원(일)×21일 | **+1,302만원**<br>*주수차등가산 + 지역우대 62만원(일)×21일 | **3,312만원** |
| 합계 | | **3,100만원** | **+3,101만원** | **6,201만원** |

| | | 지금까지는 | 앞으로는 |
|---|---|---|---|
| 진찰·입원 ('27.1월 시행) | 진찰 | 6세 미만 / 가산 5~12% | **8세 미만 / 가산 5~25%** |
| | 입원 | 8세 미만 / 가산 30~50% | **8세 미만 / 가산 40~60%** |
| 중증소아 수술·처치 ('27.1월 시행) | 중증 수술 | 600여개, 최대 1000% 가산 (가산 적용 중증수술 확대 요구) | 600여 개 가산에 더하여 **+ 1,670개 중증수술 50% 가산 (다빈도 포함)** |
| | 처치 | 소아중환자실 처치 가산 없음 | **소아중환자 가산 신설 50% 지역우대수가 50%** |
| 소아 응급 ('26.11월~ 시행) | 야간 휴일 | 달빛어린이병원 기능, 지역 무관 동일 수가 | **중등증 달빛어린이병원 및 소아 인구감소 시군구 가산** |
| | 중증 응급 | 소아전문 응급의료센터 보상 강화 요구 | **소아전문응급의료센터 응급의료관리료 인상** |

첫째, 소아에 대해서는 소아 일차진료를 강화하기 위해 **진찰료 가산 연령을 현행 6세 미만에서 8세 미만으로 상향**한다. 이에 따라 진찰과 입원 간에 서로 달리 적용된 가산 연령을 8세 미만으로 동일하게 조정하고, 입원은 **가산을 10%p 수준 높인다.**

둘째, 종합병원 이상에서 **중증·응급 수술 1,670개**의 수가를 20% 상향하는 과정에서, 같은 수술이어도 **6세 미만 소아 수술**은 난이도와 위험도가 높은 점을 고려해 **50%를 추가로 가산**한다.

셋째, **소아 중환자실*의 중증 처치**가 필요한 경우, **처치에 대한 보상을 50% 가산**하면서 **비수도권과 수도권 취약지는 50%를 가산**한다.

* 상급종합병원 및 소아중환자실이 있는 종합병원 대상

넷째, 소아청소년 야간 진료를 담당하는 **달빛 어린이병원의 중등증 소아 환자 진료 기능을 강화**하도록 **야간전문관리료를 신설**하고, **소아 인구가 적은 시군구 소재 달빛어린이병원**에는 **야간진료 수가를 30% 가산**을 신설한다.

또한 소아 중증응급 진료 강화를 위해 **소아전문응급의료센터 응급의료관리료**를 현행 **권역응급의료센터의 응급의료관리료 2배 수준으로 인상**한다.

## 5. 급성기 및 회복기 의료공급 · 이용체계 확립

첫째, 비용 대비 수익이 전반적으로 낮은 **재활 분야 중** 전문인력에 의한 재활 필요도가 높은 **전문재활치료료 수가를 10% 상향**한다. 단순 재활치료 중 적절한 재활 치료 시행을 위하여 **횟수 확대가 필요한 운동치료 등 수가를 개선**한다.

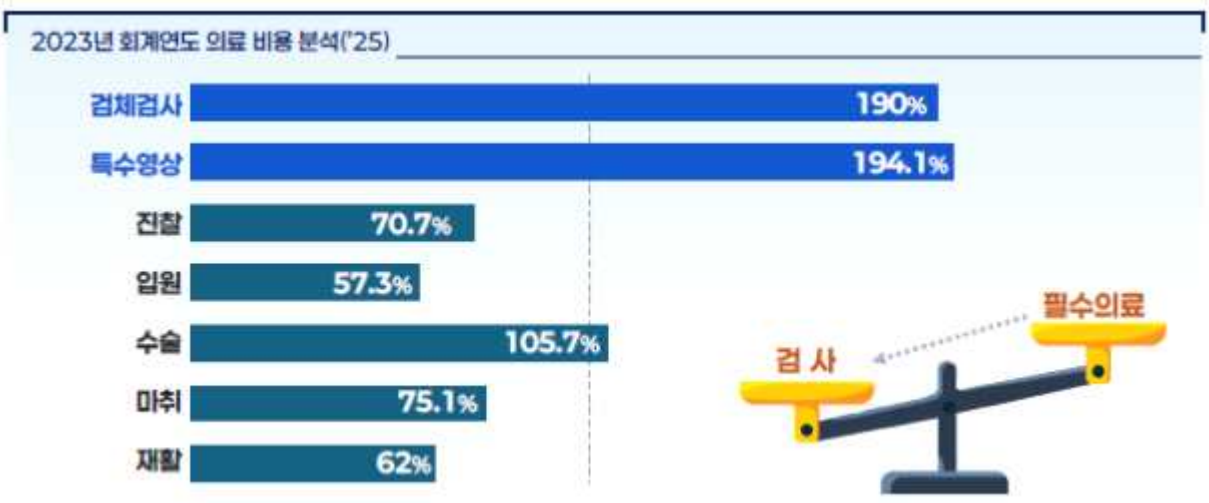
둘째, **어린이들이 맞춤형 집중 재활을 받을 수 있는 기관**을 현행 47개소에서 최대 **68개소까지 확충***할 계획이다. 또한 소아 맞춤형 집중 재활치료 대상 **연령을 6세 미만에서 9세 미만까지 확대**하고, **집중 재활에 대한 가산을 인상 (현행 3세 미만 30% → 40%~지역50%)**한다.

* 어린이재활의료기관, 공공어린이재활병원·센터(현재 47개소 → 개선 64~68개소 예상)

이러한 내용은 **내년 1월부터 적용**하고, 지난 6월 발표한 건강보험 수가 혁신방안 내용 중 포괄 2차 종합병원 보상 강화 등 **급성기 의료 공급체계 구축, 급성기 재활 의료체계 구축** 등의 내용은 **연 내 건정심에 상정하여 추진**할 예정이다.

## 6. 과보상 검사 조정 (검체, CT·MRI)

**건강보험 수가 구조의 불균형을 개선**하기 위해 **지역과 필수의료 강화를 위한 건강보험의 역할을 강화**하면서 **과보상 검사 수가 조정을 병행**한다.



검체검사, CT·MRI 검사는 **빈도를 쉽게 늘릴 수 있으며 비용 대비 수익이 과보상**되어 있어 충분한 진찰 등 필수적 기본진료보다 **검사 비중이 높아지는 구조**로 지난 6월 건정심에서 확정된 **과보상 조정 로드맵에 따른 2.6조 원 조정안**에 따라 **비용 대비 수익이 150% 넘는 검사는 조정**한다.

혈액검사 등 검체검사의 비용 대비 수익 **150% 이상 과보상된 수가를 낮추어 연 1.7조 원의 과다 지출을 줄이고, 위탁검사** 검사료의 **10%를 위탁관리료로 산정하는 제도를 폐지**하여 **2천억 원의 지출을 줄인다.**

또한, **컴퓨터단층촬영(CT)와 자기공명영상(MRI)** 검사의 비용 대비 수익 **150% 이상 과보상된 수가를 낮추어 연 7천억 원의 과다지출을 줄인다.**

다만 **진료에 필수적인 검사 환경이 안정적으로 유지**될 수 있도록 학회 등 현장 의견수렴, 청구자료 분석 및 상대가치운영기획단 논의 등을 통해 **전문가의 검증·판독**이 필요하거나 **조혈모세포이식 및 장기 이식 관련 검사 등 중증질환, 응급진료에 필수적인 검사는 조정하지 않을 계획**이다.

| 구분 | 조정 내용 | | 비고 (미세조정) |
|---|---|---|---|
| | 조정항목 | 인하재정 | |
| 검체검사 | · **과보상 38개 세분류(702항목) 인하(1.62조 원)**<br>* 과보상 41개 세분류, 745개 항목 중 미조정 제외<br>· **위탁관리료폐지(0.24조 원)** | **1.9조 원** | *진단전문의 검증료, 골수이상혈액검사, 조직적합성 면역검사 미조정(368억 원↓)<br>*감염검사 동일원리 같은 수가적용(81억 원↓) |
| 영상검사 (CT,MRI) | · **과보상 2개 세분류(480항목) 인하(7.3천억 원)**<br>* 과보상 480개 전체 항목(CT 96, MRI 384) 조정 | **7천억 원** | *영상전문의 판독료 및 응급가산 현재 규모 유지(566억 원↓)<br>*근골격계 MRI 판독료 분리(30억 원↓) |

**검사 수가 조정**과 **검체검사 위수탁 구분 지급**은 **내년 1월부터 시행**한다. 검사 수가 조정 이후 **분기별 모니터링 체계를 구축**하여, **시행 이후 영향을 지속 점검**하고, **추가적인 개선 방안은 지속 발굴, 추진**할 예정이다.

## 【 향후계획 】

지난 6월 의결한 건강보험 수가 구조 혁신방안 중 **이날 위원회에 상정한 2.7조 원**은 **11월 중 고시 개정을 거쳐 시행** 예정이며, **나머지 과제도 계획에 따라 차질 없이 이행할 예정**이다. 보건복지부는 **"건강보험 수가 혁신은 지역·필수의료 강화를 위한 필수 단계다"**라며, **"앞으로도 차질 없이 이행될 수 있도록 지속적 관리하겠다"**라고 밝혔다.

**< 환산지수-상대가치 연계 수가 조정(안) >**

정부는 **「제2차 국민건강보험 종합계획('24~'28)」**에 따라 2025년부터 **환산지수와 상대가치*를 연계**하여 **저보상 행위의 상대가치점수 인상 또는 지역·필수의료 강화에 투입**하고 있다.

* 건강보험 수가는 '행위의 상대가치점수 × 환산지수(상대가치점수 당 단가)'로 결정

행위별 건강보험 수가 보상의 불균형이 존재하는 상황에서, 환산지수의 일률적 인상은 행위 유형별 보상수준의 불균형을 심화시킬 우려가 있다. 따라서 인상분의 일부를 **저평가된 항목의 상향 조정에 투입 또는 지역·필수의료에 투입**하여 필요한 곳에 건강보험 보상을 강화하려 한다.

2027년에는 환산지수 인상률의 일부를 **상대가치점수 조정으로 연계하기로 결정한 재정**(이하 '연계재정')*을 활용하여 **의원·치과 '진찰료', 병원 '식대 및 주사료'에 대한 재정투입이 결정***되었다.

* '27년도 환산지수 협상 결과(5.30.) 및 제12차 건강보험정책심의위원회 의결(6.25.)

** 의원 1,413억 원(환산지수 인상률 1.6% 중 0.7%), 치과 99억 원(환산지수 인상률 2.6% 중 0.2%), 병원 345억 원(환산지수 인상률의 1.2 % 중 0.1%) 투입 결정

**의원, 치과**는 연계재정을 초진진찰료로 연계한다. 이에 따라 **초진진찰료 상대가치점수**가 **▲의원은 5.2%, ▲치과는 2%로 각각 높아진다.**

**병원**은 연계 재정을 **주사료 3.14% 상향**, **기본식사 단가 4.27% 상향에 투입**한다.

**【 '27년도 수가 변동(예시)】**

| 구분 | '26년 | | | '27년 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 점수 | 환산지수 | 금액 | 점수 | 환산지수 | 금액 |
| 의원<br>초진진찰료* | 197.12점 | 95.6원 | 18,840원 | 219.82 | 96.5원 | 21,210원 |
| 치과의원<br>초진진찰료 | 166.59점 | 101.1원 | 16,840원 | 169.92점 | 103.5원 | 17,590원 |
| 병원 주사료<br>골수내주사 | 289.09점 | 83.8원 | 24,230원 | 298.17점 | 84.7원 | 25,250원 |
| 병원 일반식대 | 5,150원 | | | 5,480원<br>(환산지수 연계 4.27% + 물가상승률 2.1%) | | |

* 의원급 초진진찰료는 수가혁신방안에 따라 6% 상향 + 환산지수 연계 5.2% 상향
(환자 본인부담은 검사수가 인하와 연계 시 상황에 따라 상향, 하향 가능)

보건복지부는 "**환산지수와 상대가치를 연계**하여 **저평가된 항목을 인상**하고 있으며, 그 일환으로 **내년도 환산지수 인상 재정 일부**를 활용하여 **의원·치과 진찰료, 병원 주사료 및 식대**를 인상한 것이다"라면서, "앞으로도 **필수의료 투자**를 강화하고 **의료행위 간 균형 보상체계를 확립**하기 위해 지속 개선할 예정이다"라고 밝혔다.

**< 검체검사 위·수탁* 조건부보상 추진계획 >**

* **위탁의료기관**은 환자의 혈액·조직 등 검체의 검사를 다른 기관에 의뢰하는 의료기관,
**수탁의료기관**은 의뢰받은 검체를 검사하고 그 결과를 제공하는 의료기관

**내년 1월**부터 **의원급 위탁의료기관**에서 **검사를 받는 환자**는 **수탁기관의 보다 신속하고 정확한 검사결과를 바탕**으로 **적정한 건강관리**를 받을 수 있게 된다.

**위·수탁 의료기관** 중 **검체검사 질 향상**에 **필요한 요건을 갖춘 기관**을 대상으로 **2년간 조건부 차등 보상을 실시**한다.

**의원급 위탁의료기관**은 **수탁기관** 등과 **검사결과를 신속·정확하게 공유**하는 체계를 갖추고, **만성질환자** 등에게 **검사결과에 대한 분석과 관리**를 제공하는 경우 **환자당 연 4회**까지 **임상결과 분석·관리료(회당 1,400원)를 수가**로 받을 수 있다. 또한 **환자당 평균 검사 처방량의 적정성 등 성과 수준**에 따라 **기관 단위 보상**을 받을 수 있게 된다.

**수탁기관**은 **고난도·저빈도 검사**와 **의료취약지에서 의뢰한 검사***를 수행하는 경우 해당 **검사에 대한 가산을 수가**로 받을 수 있다. 또한 **검체 관리와 검사결과 보고** 등 **검사 전 과정**의 **질 관리 및 절차 개선 성과 수준**에 따라 **기관 단위 보상**을 받을 수 있게 된다.

* 취약지 가산은 지역 우대수가와 동일 시기에 적용('27.3. 예정)

이는 검체검사 **위·수탁 거래의 투명성과 공정성**을 높이고 **검사 질과 환자 안전을 강화**하기 위해 정부가 **지난해 12월**과 **올해 6월 발표**한 **'검체검사 위·수탁제도 개편방향'**에 따라 **조건부 보상의 세부 추진계획을 확정**한 것이다.

그간 **위탁기관**이 **검사료를 일괄 지급**받아 **수탁기관과 자체 정산**하는 과정에서 **검사료 할인 경쟁**이 발생하면서 **검사 질 저하 우려가 제기**되어 왔다. 아울러 **환자의 검체가 뒤바뀌는 사고** 등으로 **검사 전 과정**의 **질 관리**와 **환자안전을 강화**할 필요성도 커졌다.

이에 정부는 **위·수탁기관의 역할에 맞게 보상체계를 정비**하고, **검사 질 향상**에 필요한 **요건과 성과에 연계**한 **조건부 보상을 도입**하여 가격 중심의 경쟁을 **질 관리 구조로 전환**하고자 한다.

특히, 조건부 보상과 함께 시행되는 **'구분지급'**은 국민건강보험공단이 **위탁기관**과 **수탁기관**에 **각각의 역할에 해당**하는 **검사료를 직접 지급**하는 방식이다. 이를 통해 위·수탁기관 간 **거래의 투명성**을 높여 수탁기관 간 **공정한 질 경쟁을 유도**할 것으로 기대된다.

보건복지부는 "이번 개편으로 **검체검사 위·수탁 보상체계가 투명**해지고 위·수탁기관의 **검사서비스 질이 높아져**, **환자**에게 **신속·정확하고 안전한 검사**가 보다 **적정하게 제공**될 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

## < 마약류 중독환자 치료지원 시범사업 >

보건복지부는 **「마약류 중독환자 치료지원 시범사업」**을 **'27년 1월부터 추진**한다.

**마약류 중독**은 치료가 필요한 질환으로, **조기에 적절한 치료**를 받으면 **재발 방지가 가능**하고 **범죄 감소, 의료비 절감** 등 사회적 비용을 낮출 수 있다.

**마약류 중독**은 복합질환을 동반하는 경우가 많아 **치료 난이도가 높고**, 환자 관리에 인력·시간 등 **자원 투입이 많이 필요**하여 **의료기관의 전문 치료행위에 대해 별도 보상이 필요**하다는 지적이 계속되어 왔다.

그간 마약류 중독 치료에 **전문적 역량과 인프라를 갖춘 기관**은 **일부 지역에 한정적**이고, **운영에 어려움**을 겪어왔다.

이번 **시범사업**에서는 마약류 중독환자가 **중독 수준 및 치료단계에 따라 집중치료, 회복치료** 등을 적절히 받은 후 **지역사회에서도 중독관리통합지원센터 등 재활기관과 연계**하여 지속 관리될 수 있도록 **수가 보상방안을 마련하여 시행할 계획**이다.

**<마약류 중독 치료 체계>**

| 초기 집중해독 | ⇒ | 회복 및 유지 | ⇒ | 지속관리 및 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 초기 급성 중독증상 완화, 약물에 대한 금단·갈망 등 정신증 집중관찰 | | 집중해독 치료 및 단약 이후 증상관리, 회복 등 유지치료 | | 지역 의료기관이나 중독관리통합지원센터 연계를 통한 사회복귀 지원 |

시범사업은 「마약류 관리에 관한 법률」 제40조에 따른 **치료보호 대상자에 대해 적용**하며, 보건복지부가 지정한 **권역치료보호기관(11개소)의 신청을 받아 시범기관으로 지정**하여 **2027년 1월부터 시행**할 계획이다.

보건복지부는 "**시범사업**을 통해 **전문적인 치료역량과 인프라를 갖춘 치료보호기관을 확충**하여, **마약류 중독환자**가 **조기에 적절한 치료를 받아 건강하게 일상을 회복할 수 있는 기반**을 **마련**하겠다"라고 밝혔다.

## < 어린이 재활의료기관 지정·운영 2기 시범사업 성과평가 >

보건복지부는 **‘제2기 어린이 재활의료기관 시범사업**(2024년 3월~2026년 12월)’ **추진성과를 보고**하고, **시범사업을 3년 연장**(3기, 2027년 1월~2029년 12월)하기로 하였다.

‘어린이 재활의료기관 시범사업’은 **장애아동 등***이 **거주지역에서 적기에 재활치료**를 받을 수 있도록 **전문인력·시설** 등을 충족한 **병·의원 등**을 지정하고, 환자의 **상병·연령** 등에 따라 **집중 재활치료 수가** 등을 적용하는 사업이다.

* 뇌성마비군, 신경근육질환군, 중도장애군, 기타 발달지연군 등 26개 상병

**< 어린이 재활의료기관 시범사업 내용 >**

- **(개요)** 장애아동의 적기 재활치료를 위해 일정 기준*을 충족한 병·의원 등을 어린이 재활의료기관으로 지정(1기 ’20.~’23, 2기 ’24.~26.)
  * 재활의학과 전문의, 물리치료사, 작업치료사, 언어재활사, 사회복지사, 간호사 등
- **(대상자)** 전문재활치료가 필요한 상병에 해당하는 만 18세 이하 환자
  * 뇌성마비군, 신경근육질환군, 중도장애군, 기타 발달지연군 등 26개 상병
- **(대상지역)** 1기 15개소(비수도권) / 2기 39개소(수도권 19개소, 비수도권 20개소)
  * 재활치료 접근성이 열악한 권역 우선 지정
- **(시범수가)** 통합재활기능평가료, 통합계획 교육상담료, 재활치료료Ⅰ~Ⅲ*, 지역사회연계료
  * 현재 비급여인 언어치료, 전산화인지재활치료 및 관리급여인 도수치료 등 포함
  ** 시범사업 참여기관 외 공공어린이재활의료병원/센터도 수가 적용

2기 시범사업 참여기관은 총 **39개소**(수도권 19개소, 비수도권 20개소)이며, 2025년도 기준, 어린이 환자 **9,260명**에게 **약 346만 회**의 전문재활치료를 제공한 바 있다.

* 전체 어린이 전문재활치료 환자의 약 30.5%, 치료횟수의 약 54.3% 차지(’25년 기준)

** 공공어린이재활의료기관 8개소 포함시(10개소 중 2개소는 시범사업에 참여 중), 전문

재활치료 환자의 약 37.7%, 치료횟수의 약 64.5% 차지('25년 기준)

시범사업 결과, 참여기관의 **재활치료 인력***과 전문 **재활치료횟수**가 증가하였고, 참여환자의 **지역 내 의료이용 제고****, **일상생활동작 등 기능개선, 비급여 부담 절감** 등의 성과가 있는 것으로 나타났다.

* 기관당 평균 인력 재활의학과 전문의('24년 3.0명 → '26년 3.2명), 물리/작업치료사('24년 65.4명 → '26년 77.4명)

** 시범사업 참여환자 중 타 의료기관 이용 경험자의 거주지 내 이용비율 13.2%p 증가

다만, 일부 권역은 참여기관 부재 등 **권역별 전문재활 이용에 편차***가 존재하고, 아동의 **집중재활치료를 위한 수가개선 필요성** 등이 있어, 시범사업을 **3년 연장**하고 **대상기관 확대, 영유아기** 및 **학령기 전문재활치료 수가 개선** 등을 추진하기로 하였다.

* 권역 내 소아 전문재활치료 이용 비율 : 대구 약 97% vs 충북 약 65%('25년)

아울러, 시범사업 기간 동안 **어린이 재활치료 제공기관* 간 전달체계 정립**, 보건소·학교·복지관 등 **지역사회 건강· 돌봄기관과의 연계 강화방안**도 모색할 계획이다.

* 급성기 종합병원-공공어린이재활병원·센터-어린이 재활의료기관 시범사업 참여기관-지역의 소아 재활 의료기관 등

**< 2기 대비 3기 시범사업 주요 변경 사항 >**

| 구분 | | 2기 시범사업('24.2~'26.12) | 3기 시범사업('27.1~'29.12) |
|---|---|---|---|
| 대상 기관 | | 총 39개소<br>* 공공어린이재활의료병원/센터 포함 시 **총 47개소** | **총 52~56개소***<br>* 공공어린이재활의료병원/센터 포함 시 **총 64개~68개소** |
| 수가개선 | 영유아기 | 3세 미만 재활치료료Ⅲ 30% 가산 | 3세 미만 재활치료료Ⅲ **40% 가산** |
| | 학령기 | 6세 미만은 기간 제한 없이 집중재활 가능 | **9세 미만**은 기간 제한 없이 집중재활 가능 |
| | 지역가산 | 없음 | 6세 미만 재활치료료Ⅲ **10%** **지역가산** 신설 |

* 3기 시범사업 대상 권역 및 참여기관 수는 심사 결과에 따라 변동 가능

** 3기 시범사업 기간 중 공공어린이재활병원/센터 13개소 운영 예정, 이 중 1개소는

시범사업 참여 예정

*** 시범사업 수가 개선 : 2026년 6월 '건강보험 수가 구조혁신 방안' 반영

보건복지부는 "권역별 소아재활 인프라 확충을 위해 **제3기 어린이재활의료기관 지정을 연말까지 추진할 계획**이며, 앞으로 양적 확대를 넘어 **소아재활의료 전달체계 정립, 돌봄 연계 강화** 등 **서비스 질 제고**를 위한 다각적인 노력을 지속하겠다"라고 밝혔다.

<붙임> 마약류 중독환자 치료지원 시범사업 개요

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 담당 부서<br><총괄> | 건강보험정책국<br>보험정책과 | 책임자 | 과 장 | 장영진 (044-202-2710) |
| | | 담당자 | 사무관 | 김종구 (044-202-2704) |
| <건강보험 수가 구조 혁신방안>, <환산지수 연계 상대가치 인상> | 건강보험정책국<br>보험급여과 | 책임자 | 과 장 | 유정민 (044-202-2730) |
| | | 담당자 | 사무관 | 이민정 (044-202-2733) |
| | | | 사무관 | 구도은 (044-202-2745) |
| <검체검사 위수탁 조건부보상> | 건강보험정책국<br>지불혁신추진단 | 책임자 | 단 장 | 공인식 (044-202-2790) |
| | | 담당자 | 사무관 | 강예나 (044-202-2793) |
| <마약류 중독환자 치료지원 시범사업> | 정신건강정책관<br>정신건강관리과 | 책임자 | 과 장 | 송명준 (044-202-3870) |
| | | 담당자 | 사무관 | 이지현 (044-202-3871) |
| <어린이재활 의료기관 시범사업> | 장애인정책국<br>장애인건강과 | 책임자 | 과 장 | 김성철 (044-202-3190) |
| | | 담당자 | 서기관 | 이태호 (044-202-3191) |

**붙임** **마약류 중독환자 치료지원 시범사업 개요**

○ **(목적)** 마약류 중독 **치료보호기관**에 대한 **보상**을 **강화**하여, 마약류 중독자가 **적기에 충분한 치료**를 받고 **지역사회**에서도 **지속 관리** 지원

○ **(대상)** 「마약류관리법」 제40조에 따라 **치료보호** 받는 건강보험 환자

○ **(시범기관) 권역치료보호기관(11개소) 중 신청을 받아 지정**

**< 권역치료보호기관 현황 ('26) >**

| 지역 | 병원명 | 지역 | 병원명 | 지역 | 병원명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국립정신건강센터 | 경기 | 경기도립정신병원 | 인천 | 인천참사랑병원 |
| | 서울특별시 은평병원 | | 이천소망병원 | 강원 | 원주세브란스기독병원 |
| 대전 | 참다남병원 | 대구 | 대동병원 | 전북 | 원광대학교병원 |
| 경남 | 국립부곡병원 | 제주 | 연강병원 | | |

○ **(사업기간)** '27.1월~'29.12월 (3년 예정)

○ **(대상기간)** 치료보호기간(1년) 내 연간 입원 3개월, 외래 1년 지원

○ **(본인부담)** 법정 본인부담률 적용 (입원 20%, 외래 40%)

* 환자 본인부담액은 「마약류관리법」에 따라 치료보호비 예산으로 별도 지원

○ **(보상방안) 초기 집중치료**부터 **회복유지, 재발방지**를 위한 **지속관리**까지 **연계되는 치료모형 및 시범 수가 개발**

| 구분 | 분류 | 점수(점) | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| ❶ 초기 집중해독 (입원) | • **마약류 중독 초기 집중 해독** (급성 중독증상 완화, 금단·갈망 등 집중 치료) | | |
| | **(1) 초기평가 및 계획수립료(1회)**<br>* 초기 평가, 중독수준 및 금단현상 등에 맞춤형 치료계획 수립 | 606.77 | 51,090 |
| | **(2) 마약중독 집중치료관찰료(일 1회)**<br>* 마약 중독 치료에 적합한 안전한 관리환경(전담직원 모니터링 등) 조성 및 치료계획에 따른 초기 집중해독치료 | 794.50 | 66,900 |
| | **(3) 중간점검료(월 1회)**<br>* 초기평가 및 집중 해독치료 계획에 따른 치료 이행 확인 및 금단·중독증상 평가 등 환자상태 중간 점검 시행 | 338.67 | 28,520 |
| | **(4) 퇴원계획 수립 및 퇴원지도료(1회)**<br>* 정신건강의학과 전문의 환자평가를 통한 퇴원 계획에 따라 정신건강전문요원 환자·가족 대상 퇴원 지도 시행 | 591.19 | 49,780 |
| ❷ 회복·유지치료 (외래) | • **마약류 단약유지 및 지속치료** (단약후 증상관리, 회복위한 유지치료) | | |
| | **(1) 초기평가 및 계획수립료(1회)**<br>* 환자상태 평가 및 단약유지·회복을 위한 치료계획 수립 | 606.77 | 51,090 |
| | **(2) 마약중독 회복·유지치료료(진료당 1회)**<br>* 지속치료를 위해 단약확인(소변검사 등) 및 치료계획에 따른 증상관리 등 | 644.33 | 54,250 |
| | **(3) 중간점검료(월 1회)** | 338.67 | 28,520 |
| ❸ 지속관리 및 연계 | • **정신의학적 사회사업 연계** | | |
| | **(1) 지역사회연계료(2회)**<br>* 퇴원 후 치료보호환자의 지속 관리를 위해 지역 의료기관, 중독관리통합지원센터 연계 | 355.25 | 29,910 |